



FICHE BONNE CONDUITE N°26 - CHUTE

CATEGORIE EVENEMENT EXCEPTIONNEL

Quand une personne fait une chute, il faut adapter sa conduite en fonction de la **gravité** de la chute. Je garde mon calme et j'évalue rapidement les symptômes et signes de blessures afin d'évaluer si la chute est grave.

Une chute est considérée comme grave lorsque les signes suivants sont présents : perte de connaissance, respiration anormale ou lente, perte de sang, gonflements, blessure grave, vomissement, pleurs incontrôlés, somnolence, confusion, désorientation, **douleurs en particulier à la tête, au cou et à la colonne vertébrale...**

Une chute grave nécessite une prise en charge par des professionnels de santé.

EN CAS DE CHUTE GRAVE

- ✓ **J'appelle immédiatement le SAMU (au 15) ou les pompiers (au 18) et l'association**
- ✓ Je **sécurise** les lieux en supprimant ou en contrôlant un **danger** éventuel
- ✓ **Je ne déplace pas** la personne ou l'enfant (sauf en cas de danger)
- ✓ Si la personne a perdu connaissance, je la mets en **position latérale de sécurité (PLS)**
- ✓ Si la personne n'a pas perdu connaissance, je lui demande de **ne pas essayer de se relever**, mais de rester au sol sans bouger, afin de ne pas aggraver une éventuelle blessure.
- ✓ Si la personne vomit, je la tourne doucement sur le côté, afin d'éviter qu'elle ne s'étouffe. S'il s'agit d'un nourrisson (moins d'un an), je le porte dans mes bras et le tourne sur le côté, afin de permettre l'écoulement du vomi.

EN CAS DE CHUTE SANS GRAVITE

- ✓ En fonction de la situation, je **sécurise** les lieux en supprimant ou en contrôlant un danger éventuel
- ✓ Si la personne peut et souhaite collaborer, je lui mets à disposition une **chaise** sur laquelle elle s'appuiera pour se mettre à « quatre-pattes » puis se relever
- ✓ **Je ne relève pas moi-même la personne du sol** (sauf si c'est un enfant), je la **guide** en accompagnant ses mouvements. Si elle ne peut pas se relever, j'appelle le SAMU (au 15) ou les pompiers (au 18) et l'association
- ✓ Une fois relevée, j'installe la personne confortablement et en sécurité. Je la rassure et je lui donne à boire.
- ✓ En cas de **plaie simple, sans gravité** (ex : juste une égratignure) et sans complications (ex : maladie), je réalise un **soin simple** :
 - Rincer la plaie à l'eau et au savon, retirer les impuretés avec une compresse
 - Sécher avec une compresse
 - Mettre une solution anti-séptique
 - Couvrir avec un pansement stérile
- ✓ J'informe l'association, qui préviendra l'entourage
- ✓ Je **trace la chute** dans le dossier de la personne / le cahier de liaison
- ✓ Si un ou plusieurs des signes graves cités ci-dessus apparaissent dans les minutes ou heures qui suivent, ou en cas de doute, **j'appelle immédiatement le SAMU (au 15) ou les pompiers (au 18) et l'association**



Comment réagir si la personne accompagnée ou les proches-aidants ne souhaitent pas que j'appelle les secours après une chute grave ?

Il arrive que certaines personnes expriment à l'avance, ou au moment de la chute, le souhait de ne pas être emmené à l'hôpital même si la chute est grave (mot dans le cahier de liaison, aidant présent refusant la prise en charge...). Etant donné les risques pour la personne, il est du **rôle** et de la **responsabilité** de l'ADMR de prévenir les secours.

1. J'explique à la personne/les proches-aidants réticents mon **obligation** d'appeler les secours
2. En cas de forte opposition, j'appelle l'association pour qu'elle prévienne les secours
3. Je sécurise les lieux en supprimant ou en contrôlant un danger éventuel
4. Je reste auprès de la personne si les circonstances le permettent

PREVENTION DES RISQUES :

- ✓ J'évalue la capacité de la personne qui a chuté à **se relever par elle-même** et l'encourage à le faire. La participation de la personne est capitale afin de ne pas prendre **le risque de me blesser** ou de la blesser en étant entraîné dans une nouvelle chute.
- ✓ En cas de plaie simple nécessitant un soin, je porte des gants à usage unique